PATRÍCIO ALMEIDA

ATENÇÃO PRIMÁRIA, REGIONALIZAÇÃO E SAÚDE MATERNO-INFANTIL NO ESTADO DO AMAPÁ, 2022–2026

Estudo complementar para a transição de governo 2026/2027 (CNES, SIA, SIH, SINASC, SIM/DATASUS)

MACAPÁ

2026

PATRÍCIO ALMEIDA

ATENÇÃO PRIMÁRIA, REGIONALIZAÇÃO E SAÚDE MATERNO-INFANTIL NO ESTADO DO AMAPÁ, 2022–2026

Estudo complementar para a transição de governo 2026/2027 (CNES, SIA, SIH, SINASC, SIM/DATASUS)

Estudo complementar elaborado como subsídio técnico à equipe de transição de governo do Estado do Amapá, área da saúde (Secretaria de Estado da Saúde – SESA/AP), com base em dados públicos do CNES, SIH, SIA, SINASC, SIM e IBGE extraídos em 7 de novembro de 2026.

MACAPÁ

2026

RESUMO

Este estudo complementa o levantamento geral da saúde no Amapá para a transição de governo 2026/2027 com o diagnóstico da atenção primária à saúde, da regionalização da rede e da saúde materno-infantil na série 2022–2026, a partir do CNES, SIH, SIA, SINASC e SIM (DATASUS) e do IBGE. As equipes de Saúde da Família cresceram 41% (199 em 2022, 280 em 2026) e a cobertura potencial alcançou 100% em 15 dos 16 municípios, com 2.880 habitantes por equipe, mas a cobertura efetiva não acompanhou: apenas 60,3% dos nascidos vivos de 2025 tiveram sete ou mais consultas de pré-natal (26ª posição entre as UFs) e as internações por condições sensíveis à atenção primária subiram 27%, de 7.544 para 9.593, puxadas por pneumonias, doenças cerebrovasculares, infecções urinárias, diabetes e insuficiência cardíaca. O Estado mantém 139 leitos de UTI adulto com apenas 19 habilitados pelo Ministério da Saúde, o que implica perda de custeio federal. A razão de mortalidade materna do triênio 2022–2024 (82,3 por 100 mil nascidos vivos) é a segunda maior do país e a mortalidade infantil (17,8 por mil em 2024) a terceira, com predomínio de causas evitáveis e investigação incompleta dos óbitos. A assistência ao parto concentra-se em Macapá (72%), com retração em Santana e novo polo em Porto Grande. O estudo propõe a habilitação dos leitos aptos, um plano de redução da mortalidade materna e infantil, metas pactuadas de pré-natal e de ICSAP por município e a revisão da regionalização das maternidades.

Palavras-chave: Atenção primária à saúde; Estratégia Saúde da Família; internações sensíveis à atenção primária; mortalidade materna; mortalidade infantil; Amapá.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Equipes de atenção primária cadastradas no CNES por tipo, Amapá, 2022–2026..... 12
Figura 2 – Cobertura potencial da atenção primária por município, Amapá, set./2026 14
Figura 3 – Internações por condições sensíveis à atenção primária de residentes do Amapá, 2022–2025..... 15
Figura 4 – Internações sensíveis à atenção primária por grupo de causas, Amapá, 2025 (dez maiores)..... 16
Figura 5 – Leitos de UTI adulto existentes e habilitados pelo Ministério da Saúde, Amapá, 2022–2026..... 17
Figura 6 – Proporção de nascidos vivos com sete ou mais consultas de pré-natal por município, Amapá, 2025..... 19
Figura 7 – Proporção de nascidos vivos com sete ou mais consultas de pré-natal por UF, 2024..... 20
Figura 8 – Nascidos vivos por município de ocorrência do parto, Amapá, 2022–2025 (exceto Macapá)..... 21
Figura 9 – Razão de mortalidade materna, Amapá, 2022–2025..... 22
Figura 10 – Taxa de mortalidade infantil por município de residência, Amapá, média 2023–2025..... 23

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Equipes de atenção primária cadastradas no CNES, Amapá, dez./2022 a set./2026.....12
Tabela 2 – Cobertura potencial da atenção primária por município, Amapá, set./2026 13
Tabela 3 – Internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP) de residentes do Amapá, por grupo de causas, 2022–2026.....15
Tabela 4 – Leitos de UTI existentes (CNES) e habilitados pelo Ministério da Saúde, Amapá, 2022–2026.....17
Tabela 5 – Indicadores do nascimento por município de residência da mãe, Amapá, 2022 e 2025.....19
Tabela 6 – Óbitos maternos, fetais e infantis e indicadores derivados, Amapá, 2022–2026.....22
Tabela 7 – Indicadores de atenção primária e materno-infantil: Amapá, Brasil e posição entre as UFs.....24

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AIH	Autorização de Internação Hospitalar
APS	Atenção Primária à Saúde
CID-10	Classificação Estatística Internacional de Doenças, 10ª revisão
CNES	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
DATASUS	Departamento de Informática do SUS
ESF	Estratégia Saúde da Família / Equipe de Saúde da Família
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICSAP	Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária
NASF	Núcleo de Apoio à Saúde da Família
RMM	Razão de Mortalidade Materna
SESA/AP	Secretaria de Estado da Saúde do Amapá
SIA/SUS	Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS
SIH/SUS	Sistema de Informações Hospitalares do SUS
SIM	Sistema de Informações sobre Mortalidade
SINAN	Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SINASC	Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
SUS	Sistema Único de Saúde
TMI	Taxa de Mortalidade Infantil
UBS	Unidade Básica de Saúde
UF	Unidade da Federação
UTI	Unidade de Terapia Intensiva
eAP	Equipe de Atenção Primária
eMulti	Equipe Multiprofissional
eSB	Equipe de Saúde Bucal

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....8
1.1 Objetivo e contexto.....8
1.2 Objeto.....8
1.3 Período.....8
1.4 Fontes e extração.....8
1.5 Limitações.....9
2 SÍNTESE DOS ACHADOS.....10
3 REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA.....12
3.1 Equipes e cobertura.....12
3.2 Produção registrada e lacuna de informação.....14
4 INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA.....15
5 HABILITAÇÕES E REGIONALIZAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA.....17
6 NASCIMENTOS E ASSISTÊNCIA AO PARTO.....19
7 MORTALIDADE MATERNA, FETAL E INFANTIL.....22
8 COMPARATIVO ENTRE UFS.....24
9 PONTOS DE ATENÇÃO PARA A TRANSIÇÃO.....25
9.1 Leitos de UTI sem habilitação.....25
9.2 Mortalidade materna e infantil.....25
9.3 Cobertura efetiva versus potencial.....25
9.4 Regionalização do parto e das urgências.....25
9.5 Doenças crônicas na APS.....25
9.6 Informação.....26
10 RECOMENDAÇÕES E AGENDA DOS PRIMEIROS 100 DIAS.....27
11 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....28
APÊNDICE A – CONTEÚDO DA PLANILHA DE TABELAS.....29
REFERÊNCIAS.....30

1 INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo e contexto

Este estudo complementa o levantamento geral da saúde no Amapá para a transição de governo 2026/2027 (ALMEIDA, 2026) com o diagnóstico da atenção primária à saúde (APS), da regionalização da rede e da saúde materno-infantil no período 2022–2026. A atenção primária é de gestão municipal, mas o Estado é responsável pela coordenação regional, pelo cofinanciamento, pelo apoio técnico e pela rede de referência (maternidades, UTI neonatal, regulação). Os indicadores aqui reunidos permitem à equipe de transição medir o quanto a expansão de equipes se converteu em acesso, resolutividade e redução de mortes evitáveis.

1.2 Objeto

Equipes de atenção primária e habilitações de serviços registradas no CNES; produção ambulatorial de atenção básica no SIA/SUS; internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP) de residentes do Amapá (SIH/SUS); nascidos vivos por município de residência e por município de ocorrência (SINASC); óbitos infantis, fetais e maternos (SIM); comparativos entre as unidades da federação.

1.3 Período

Série 2022–2026: 2022 como ano-base, 2023 a 2025 como anos completos e 2026 parcial (CNES até setembro; SIH até agosto; SINASC e SIM com dados preliminares de 2025 e parciais de 2026).

1.4 Fontes e extração

Tabulações do TABNET/DATASUS (CNES, SIH, SIA, SINASC, SIM) e API SIDRA do IBGE, extraídas em 7/11/2026 por scripts reproduzíveis que acompanham o documento. A cobertura potencial da APS segue o parâmetro da Política Nacional de Atenção Básica usado pelo e-Gestor (3.450 pessoas por equipe de Saúde da Família e 3.000 por equipe de Atenção Primária, limitada a 100% da população). As ICSAP foram aproximadas da Lista Brasileira (Portaria SAS 221/2008) a partir da Lista de Morbidade CID-10 do TABNET.

1.5 Limitações

(a) O e-Gestor AB/SISAB (cobertura por cadastro, indicadores de desempenho do financiamento federal) e o SI-PNI (vacinação) não estavam acessíveis, por isso a cobertura aqui calculada é potencial, não efetiva; (b) desde 2021 a produção da APS é registrada no SISAB e não no SIA/SUS, que capta apenas parte dos procedimentos de atenção básica; (c) a aproximação da lista de ICSAP não contempla integralmente alguns grupos (infecções urinárias, condições do pré-natal); (d) taxas por município com pequenos números são instáveis e foram apresentadas como médias trienais quando possível.

2 SÍNTESE DOS ACHADOS

Os dez achados centrais são apresentados a seguir e detalhados nas seções 3 a 8.

1) **A rede de atenção primária cresceu 41% em equipes de Saúde da Família** (199 em dezembro de 2022, 280 em setembro de 2026) e 65% em equipes de saúde bucal (147 para 242), com cobertura potencial de 100% da população em 15 dos 16 municípios (Santana: 87%). O Amapá tem 2.880 habitantes por equipe, contra 3.720 na média nacional, e está entre as seis UFs com maior cobertura potencial.
2) **A cobertura potencial não se converteu em cobertura efetiva de cuidado.** Apenas 60,3% dos nascidos vivos de 2025 tiveram sete ou mais consultas de pré-natal (55,5% em 2024, 26ª posição entre as UFs; Brasil: 79,1%), e as internações por condições sensíveis à atenção primária cresceram de 7.544 (2022) para 9.593 (2025), ou 119 por 10 mil habitantes, puxadas por pneumonias (3.609), doenças cerebrovasculares (1.127, mais que o dobro de 2022), infecções urinárias (926), diabetes (555) e insuficiência cardíaca (374).
3) **O Estado opera UTIs sem habilitação federal.** Em setembro de 2026 o CNES registra 139 leitos de UTI adulto existentes, mas apenas 19 habilitados pelo Ministério da Saúde (12 até 2024); em UTI pediátrica, 31 existentes e 20 habilitados; em UTI neonatal, 53 e 40. Cada leito não habilitado deixa de receber o custeio federal da diária de UTI e sobrecarrega o Tesouro estadual.
4) **A mortalidade materna é a segunda maior do país:** razão de 82,3 óbitos por 100 mil nascidos vivos no triênio 2022–2024 (Brasil: 53,7), com 39 óbitos maternos entre 2022 e 2025, 77% por causas obstétricas diretas (hipertensão, hemorragia, aborto), isto é, evitáveis com pré-natal, parto e puerpério de qualidade. Em 2025 (preliminar) houve 7 óbitos (55,5 por 100 mil).
5) **A mortalidade infantil permanece a terceira maior do Brasil** (17,8 por mil nascidos vivos em 2024; média de 18,7 no triênio 2023–2025) e é mais alta no interior: Ferreira Gomes (27,2), Calçoene (25,2), Pedra Branca do Amapari (24,1), Oiapoque (22,5), Laranjal do Jari (21,9) e Porto Grande (21,4) superam a média estadual no triênio. Um quarto a um terço dos óbitos infantis (24,6% em 2024; 31,2% em 2025) não é investigado.

6) **A assistência ao parto está se regionalizando, mas de forma desigual:** Macapá concentra 72% dos partos de ocorrência; Santana perdeu 28% dos partos realizados (2.496 em 2022 para 1.807 em 2025) e Porto Grande passou de 55 para 596 partos com a transformação do Hospital Maria Lúcia Guimarães da Silva em polo; Laranjal do Jari (756) e Oiapoque (460) mantêm maternidades regionais. A cesariana subiu de 38,8% para 46,9% dos nascimentos, ainda abaixo da média nacional (60,6%), mas com Laranjal do Jari, Santana, Macapá e Porto Grande acima de 48%.
7) **Os determinantes do pré-natal insuficiente são locais:** em 2025, menos da metade dos nascidos vivos de Itaubal (47,0%), Mazagão (47,4%) e Ferreira Gomes (49,2%) teve sete ou mais consultas, enquanto Laranjal do Jari alcançou 76,7%; a gravidez na adolescência atinge 28,6% em Pracuúba, 26,3% em Vitória do Jari e 25,6% em Cutias (média estadual 17,7%); a prematuridade chegou a 22,0% em Laranjal do Jari e 21,2% em Serra do Navio.
8) **Os óbitos fetais caíram de 164 (2022) para 120 (2025)**, taxa de 11,9 para 9,4 por mil nascimentos, mas 21% dos óbitos fetais de 2024 não foram investigados, e a maioria ocorre entre 22 e 36 semanas, janela em que o pré-natal pode intervir.
9) **A regionalização da rede especializada avançou em habilitações recentes:** 19 estabelecimentos habilitados no Programa Mais Acesso a Especialistas, 10 no Programa Nacional de Redução de Filas, 12 Centros Especializados em Reabilitação, 5 Centros de Especialidades Odontológicas, 8 CAPS, 3 serviços de hemodiálise e 1 UNACON com radioterapia; fora de Macapá, porém, as habilitações se concentram em Santana e Laranjal do Jari.
10) **A informação de atenção primária disponível ao público é insuficiente para gestão.** A produção da APS migrou para o SISAB, e o SIA/SUS registra apenas 1,97 milhão de procedimentos de atenção básica em 2025, 84% deles em Macapá, com municípios sem registro; a transição deve obter da SESA e do COSEMS os indicadores de cadastro, vínculo e qualidade do cofinanciamento federal por município.

3 REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

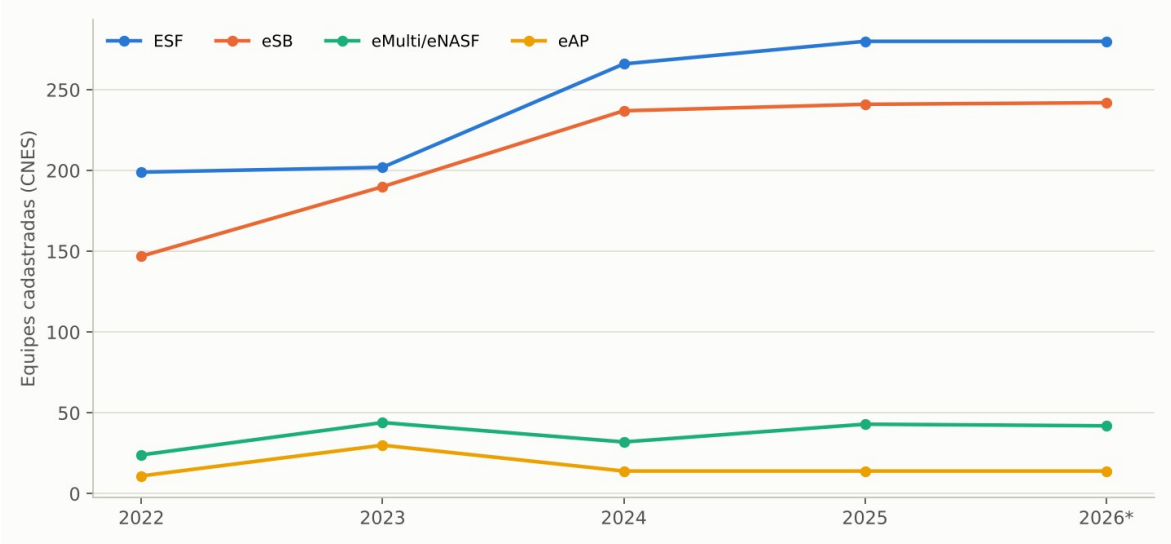
3.1 Equipes e cobertura

Tabela 1 – Equipes de atenção primária cadastradas no CNES, Amapá, dez./2022 a set./2026

Tipo de equipe	dez/2022	dez/2023	dez/2024	dez/2025	set/2026	Var. 2022–2026
Equipe de Saúde da Família (ESF)	199	202	266	280	280	+41%
Equipe de Saúde Bucal (eSB)	147	190	237	241	242	+65%
Equipe multiprofissional (eNASF/eMulti)	24	44	32	43	42	+75%
Equipe de Atenção Primária (eAP)	11	30	14	14	14	+27%
Equipe de Atenção Primária Prisional	2	2	5	5	5	+150%
Consultório na Rua	2	4	4	4	4	+100%
Atenção domiciliar (EMAD)	5	6	6	6	6	+20%
Total de equipes	**392**	**481**	**567**	**596**	**596**	**+52%**

Fonte: CNES/DATASUS (BRASIL, 2026) (aba *EQUIPES_tipo_ano*).

Figura 1 – Equipes de atenção primária cadastradas no CNES por tipo, Amapá, 2022–2026



Fonte: elaboração própria a partir de CNES/DATASUS (BRASIL, 2026).

O número de equipes de Saúde da Família cresceu 41% em quatro anos, com o salto concentrado em 2024 (de 202 para 266), sobretudo em Macapá (de 88 equipes em 2022 para 161 em 2026). Pelo parâmetro de 3.450 pessoas por equipe, a cobertura potencial do estado passou de 85,5% (2022) para 100% (2026), e o Amapá tem 2.880 habitantes por ESF, densidade superior à média nacional (3.720)

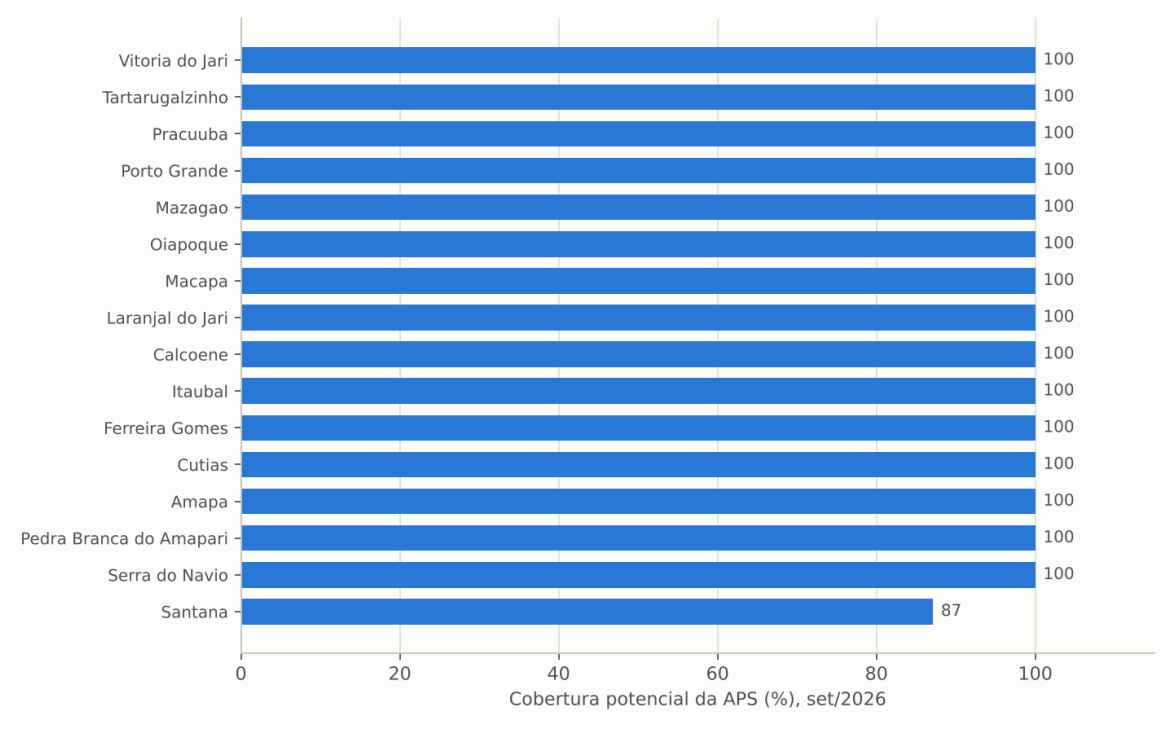
e a sexta maior cobertura potencial entre as UFs. Santana é o único município abaixo de 100% (30 equipes para 118.803 habitantes, 3.960 pessoas por equipe, cobertura de 87%). As equipes de saúde bucal acompanharam a expansão (242) e as equipes multiprofissionais, prisionais e de consultório na rua dobraram ou mais, ainda que em números pequenos.

Tabela 2 – Cobertura potencial da atenção primária por município, Amapá, set./2026

Município	População 2025	ESF dez/2022	ESF set/2026	eAP	eSB	Cobertura potencial APS (%)	Pessoas por ESF
Macapá	489.676	88	161	0	134	100	3.041
Santana	118.803	30	30	0	25	87	3.960
Laranjal do Jari	37.872	20	20	0	16	100	1.894
Oiapoque	30.786	7	10	1	5	100	3.079
Mazagão	23.773	9	10	0	11	100	2.377
Porto Grande	19.048	8	9	0	9	100	2.116
Pedra Branca do Amapari	13.888	5	5	0	5	100	2.778
Tartarugalzinho	13.816	5	6	6	7	100	2.303
Vitória do Jari	11.899	7	8	2	7	100	1.487
Calçoene	11.461	4	4	2	4	100	2.865
Amapá (município)	8.440	3	3	1	3	100	2.813
Ferreira Gomes	7.184	4	4	0	4	100	1.796
Itaubal	6.097	2	2	2	4	100	3.048
Serra do Navio	5.003	3	3	0	3	100	1.668
Cutias	4.723	2	2	0	2	100	2.362
Pracuúba	4.048	2	3	0	3	100	1.349
Amapá	**806.517**	**199**	**280**	**14**	**242**	**100**	**2.880**

Fonte: CNES/DATASUS e IBGE (aba *COBERTURA_APS_mun*). ESF inclui equipes ribeirinhas e fluviais. Cobertura potencial limitada a 100%.

Figura 2 – Cobertura potencial da atenção primária por município, Amapá, set./2026



Fonte: elaboração própria a partir de CNES/DATASUS e IBGE (BRASIL, 2026).

3.2 Produção registrada e lacuna de informação

O SIA/SUS registrou 1,97 milhão de procedimentos de atenção básica em 2025 (769 mil em 2022), 84% em Macapá, mas esse número não representa a produção real da APS: desde 2021 os atendimentos individuais, visitas e procedimentos das equipes são registrados no SISAB/e-SUS APS, e o SIA capta sobretudo testes rápidos, odontologia, vigilância e atendimentos de enfermagem de unidades específicas. Municípios como Mazagão (135 procedimentos em 2025), Pracuúba (nenhum) e Oiapoque (4 mil) praticamente não aparecem no SIA, o que não significa ausência de atendimento. Para avaliar a APS a nova gestão precisa dos relatórios do SISAB por município (cadastros, vínculos, indicadores do cofinanciamento federal, como gestantes com pré-natal e exames, hipertensos e diabéticos acompanhados, cobertura vacinal e saúde bucal), que não estão em bases públicas acessíveis.

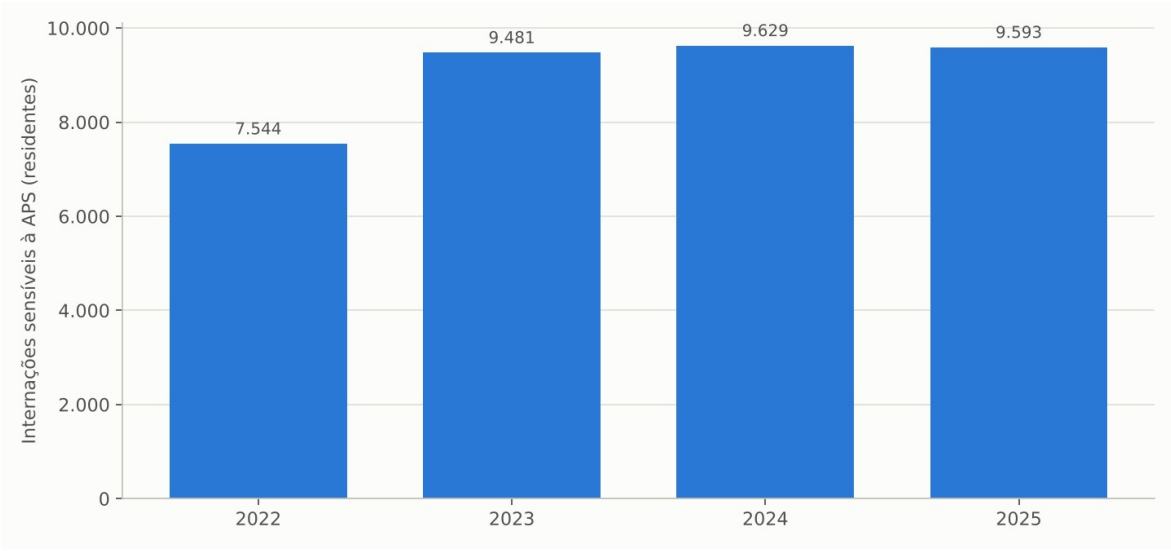
4 INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA

Tabela 3 – Internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP) de residentes do Amapá, por grupo de causas, 2022–2026

Grupo (Lista Brasileira, aproximada)	2022	2023	2024	2025	2026 (jan–ago)	Var. 2022–2025
Pneumonias bacterianas	3.445	4.365	3.874	3.609	2.696	+5%
Doenças cerebrovasculares	475	736	815	1.127	954	+137%
Infecção no rim e trato urinário	622	892	1.006	926	691	+49%
Infecção da pele e tecido subcutâneo	529	596	786	664	465	+26%
Diabetes mellitus	363	528	425	555	417	+53%
Gastroenterites infecciosas	468	440	529	535	416	+14%
Insuficiência cardíaca	231	343	395	374	283	+62%
Doenças pulmonares (DPOC, bronquites)	299	502	625	499	369	+67%
Epilepsias	130	135	223	265	261	+104%
Asma	244	219	256	241	126	-1%
Hipertensão	172	211	132	198	144	+15%
Demais grupos (imunopreveníveis, anemia, desnutrição, otites, úlcera, angina, DIP)	566	514	563	600	484	+6%
Total ICSAP (aproximação)	**7.544**	**9.481**	**9.629**	**9.593**	**7.306**	**+27%**
Internações de residentes, exceto obstétricas	24.219	40.246	40.521	41.100	32.324	+70%
ICSAP sobre internações não obstétricas (%)	31,1	23,6	23,8	23,3	22,6	—
ICSAP por 10 mil habitantes	—	—	119,9	118,9	—	—

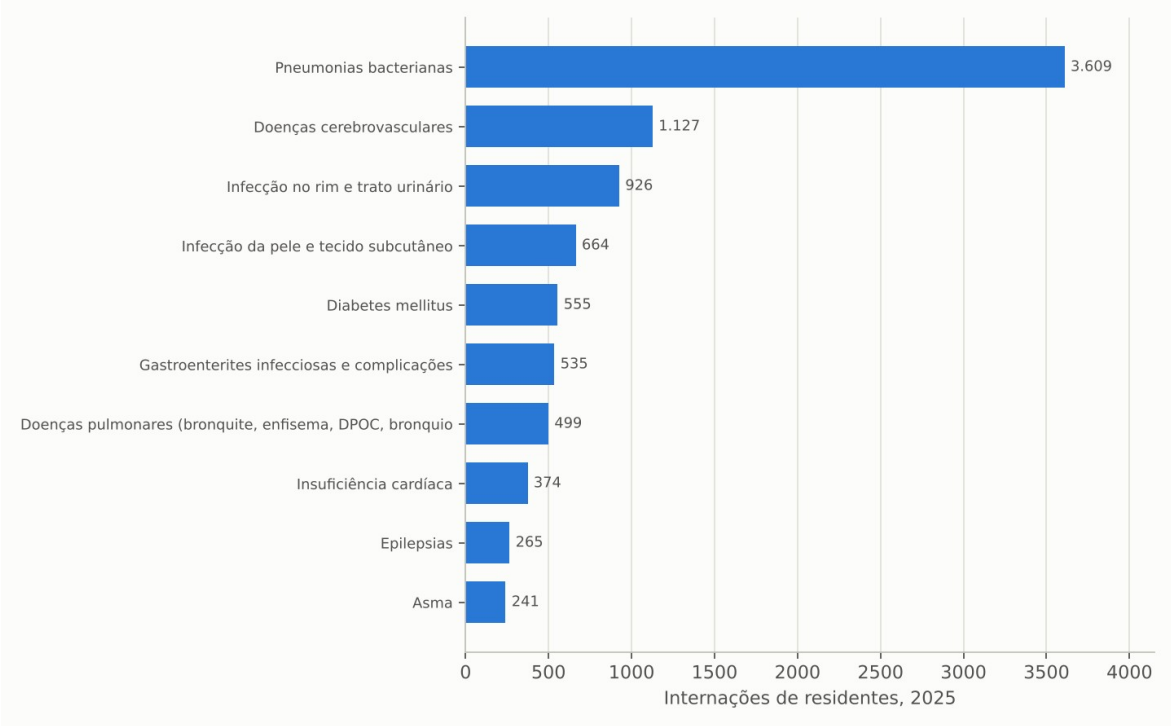
Fonte: SIH/SUS, morbidade por local de residência (aba *ICSAP_grupos_ano*). Aproximação da Portaria SAS 221/2008 pela Lista de Morbidade CID-10.

Figura 3 – Internações por condições sensíveis à atenção primária de residentes do Amapá, 2022–2025



Fonte: elaboração própria a partir de SIH/SUS/DATASUS (BRASIL, 2026).

Figura 4 – Internações sensíveis à atenção primária por grupo de causas, Amapá, 2025 (dez maiores)



Fonte: elaboração própria a partir de SIH/SUS/DATASUS (BRASIL, 2026).

As internações sensíveis à atenção primária cresceram 27% entre 2022 e 2025 (7.544 para 9.593), ritmo próximo ao crescimento populacional das equipes, o que indica que a expansão de ESF ainda não reduziu a demanda hospitalar evitável. A queda da participação relativa (31,1% para 23,3% das internações não obstétricas) é artificial: decorre do salto de internações eletivas vasculares e cirúrgicas a partir de 2023, não da redução das ICSAP. Os grupos que mais cresceram são justamente os marcadores de controle de doenças crônicas na APS: doenças cerebrovasculares (+137%), epilepsias (+104%), doenças pulmonares crônicas (+67%), insuficiência cardíaca (+62%) e diabetes (+53%). As pneumonias (3.609 em 2025), concentradas em menores de 5 anos e idosos, respondem por 38% das ICSAP e dependem de vacinação, manejo precoce e acesso oportuno. A taxa de 119 ICSAP por 10 mil habitantes em 2025 deve ser pactuada como indicador de resultado com os municípios, com metas por grupo de causa.

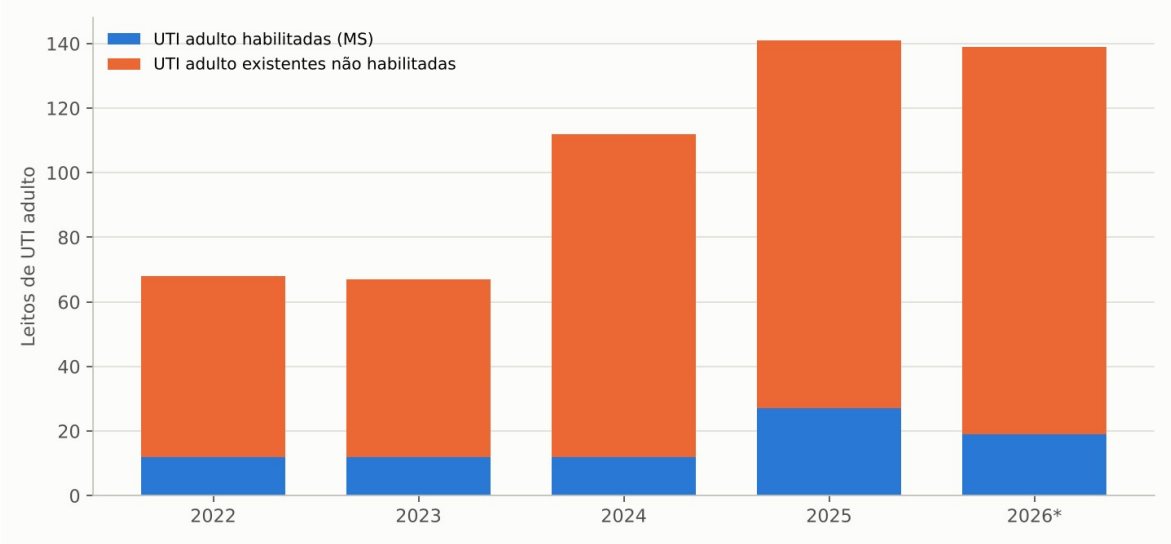
5 HABILITAÇÕES E REGIONALIZAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA

Tabela 4 – Leitos de UTI existentes (CNES) e habilitados pelo Ministério da Saúde, Amapá, 2022–2026

Tipo de leito	dez/2022	dez/2023	dez/2024	dez/2025	set/2026
UTI adulto existentes (CNES)	68	67	112	141	139
UTI adulto habilitadas (MS)	12	12	12	27	19
UTI pediátrica existentes	20	20	20	36	31
UTI pediátrica habilitadas	5	5	5	20	20
UTI neonatal existentes	50	53	53	53	53
UTI neonatal habilitadas	40	40	40	40	40
UCI neonatal convencional habilitadas	39	44	44	44	44

Fonte: CNES/DATASUS (abas *UTI_existentes_x_habilitadas*, *HABILITACOES_leitos_ano*).

Figura 5 – Leitos de UTI adulto existentes e habilitados pelo Ministério da Saúde, Amapá, 2022–2026



Fonte: elaboração própria a partir de CNES/DATASUS (BRASIL, 2026).

O quadro esclarece a divergência apontada no estudo geral entre leitos de UTI "existentes" e "SUS": os 19 leitos de UTI adulto classificados como SUS no CNES são exatamente os habilitados pelo Ministério da Saúde. Entre 2022 e 2024 o Estado manteve de 67 a 112 leitos de UTI adulto com apenas 12 habilitados; em 2025 obteve a habilitação de 19 leitos tipo II e 15 de UTI pediátrica, mas, em setembro de 2026, 120 leitos de UTI adulto (86% dos existentes), 11 pediátricos e 13 neonatais seguem sem habilitação, sem a diária federal correspondente e, em parte, operados por prestadores privados contratados. A habilitação dos leitos que cumprem os requisitos (equipe, equipamentos, registro) é uma das medidas de maior retorno financeiro disponível à nova gestão.

As demais habilitações registradas em setembro de 2026 (aba *HABILITACOES_set2026*) mostram uma rede especializada em expansão recente, mas concentrada: 19 estabelecimentos no Programa Mais Acesso a Especialistas e 10 no Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas (ambos de 2025–2026), 12 Centros Especializados em Reabilitação (4 físicos, 4 intelectuais, 2 auditivos, 2 visuais), 5 Centros de Especialidades Odontológicas, 8 CAPS, 3 serviços de hemodiálise e 1 de diálise peritoneal, 1 UNACON com radioterapia, 1 unidade de alta complexidade cardiovascular, 1 serviço hospitalar para aids e 1 hospital tipo II em urgência. Fora de Macapá (54 habilitações), apenas Santana (13), Laranjal do Jari (10), Oiapoque (5) e Porto Grande (5) têm conjuntos de serviços habilitados; Mazagão e Pedra Branca do Amapari têm uma habilitação cada (CAPS I e CEO) e os nove municípios restantes dependem integralmente da referência.

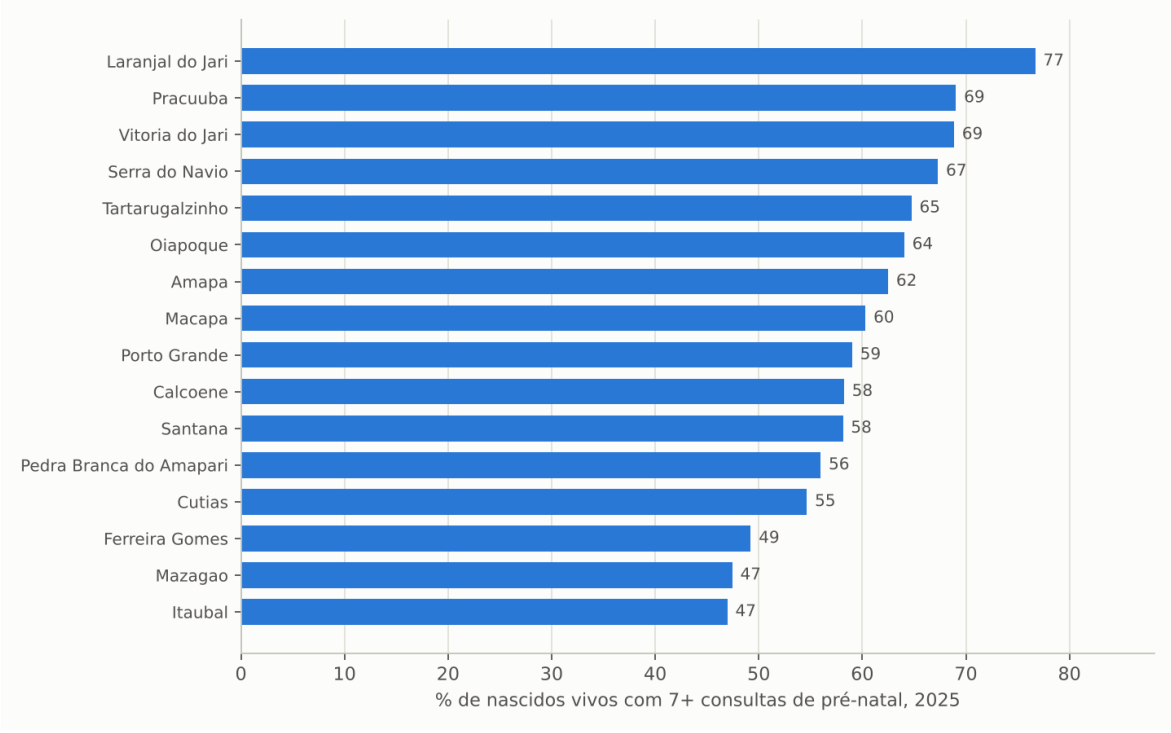
6 NASCIMENTOS E ASSISTÊNCIA AO PARTO

Tabela 5 – Indicadores do nascimento por município de residência da mãe, Amapá, 2022 e 2025

Município	NV 2025	Pré-natal 7+ cons. 2022 (%)	Pré-natal 7+ cons. 2025 (%)	Cesáreas 2025 (%)	Mães 10–19 anos 2025 (%)	Prematuros 2025 (%)	Baixo peso 2025 (%)
Macapá	7.481	48,8	60,3	49,0	15,9	12,9	9,6
Santana	1.765	44,5	58,1	51,4	18,1	14,2	9,3
Laranjal do Jari	558	60,7	76,7	53,6	20,8	22,0	6,6
Oiapoque	523	47,4	64,1	40,3	19,9	16,3	10,7
Mazagão	489	41,6	47,4	38,7	21,9	11,9	8,2
Porto Grande	327	66,0	59,0	48,9	22,0	16,8	12,2
Tartarugalzinho	278	54,0	64,7	31,3	21,9	11,5	7,2
Pedra Branca do Amapari	234	52,1	56,0	27,8	24,8	13,2	7,3
Calçoene	170	66,7	58,2	31,2	17,6	17,1	11,2
Vitória do Jari	167	67,0	68,9	42,5	26,3	15,0	5,4
Amapá	**136**	**66,3**	**62,5**	**25,7**	**14,7**	**8,8**	**5,9**
Itaubal	132	44,6	47,0	33,3	22,7	15,2	9,8
Ferreira Gomes	130	48,3	49,2	40,0	23,8	16,9	6,9
Cutias	86	39,6	54,7	36,0	25,6	8,1	4,7
Pracuúba	84	32,1	69,0	28,6	28,6	15,5	6,0
Serra do Navio	52	62,3	67,3	46,2	17,3	21,2	11,5
Amapá	**12.612**	**49,6**	**60,3**	**46,9**	**17,7**	**13,8**	**9,3**

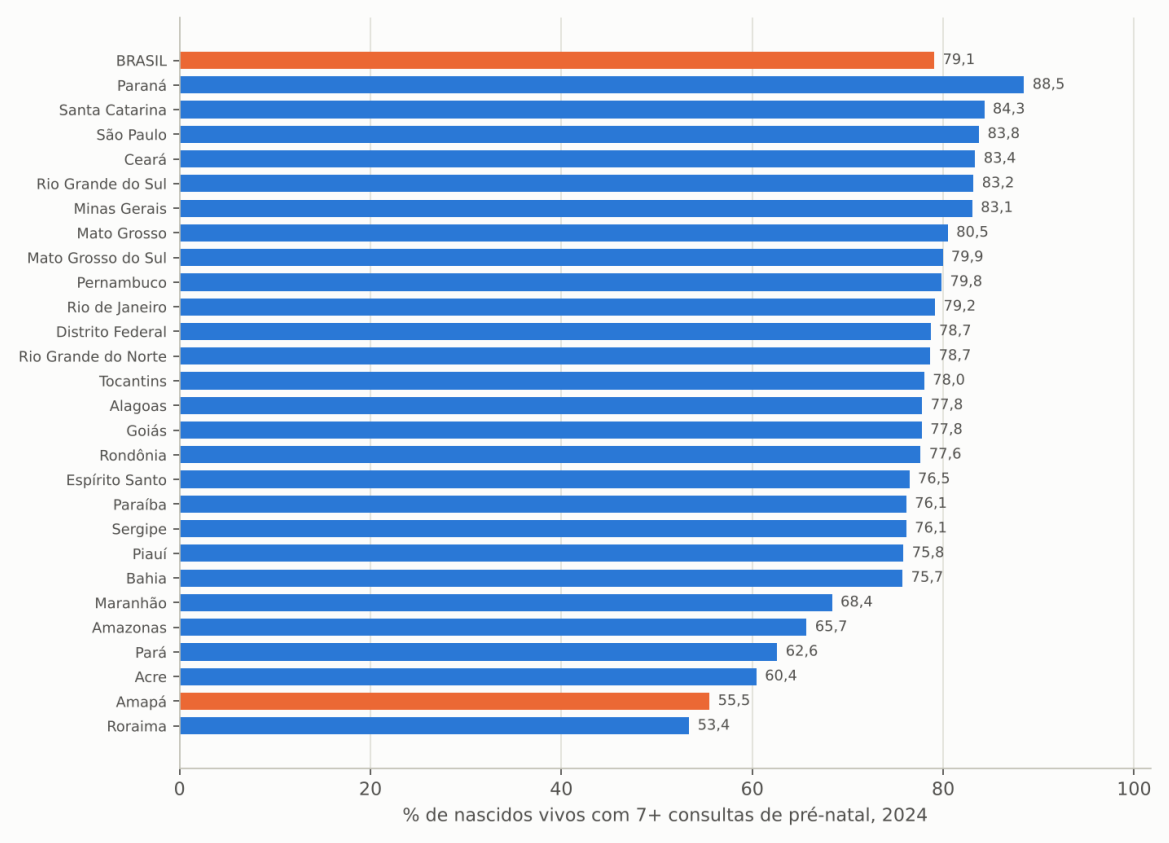
Fonte: SINASC/DATASUS (aba *MATERNO_INFANTIL_mun*). NV = nascidos vivos; 2025 preliminar.

Figura 6 – Proporção de nascidos vivos com sete ou mais consultas de pré-natal por município, Amapá, 2025



Fonte: elaboração própria a partir de SINASC/DATASUS (BRASIL, 2026).

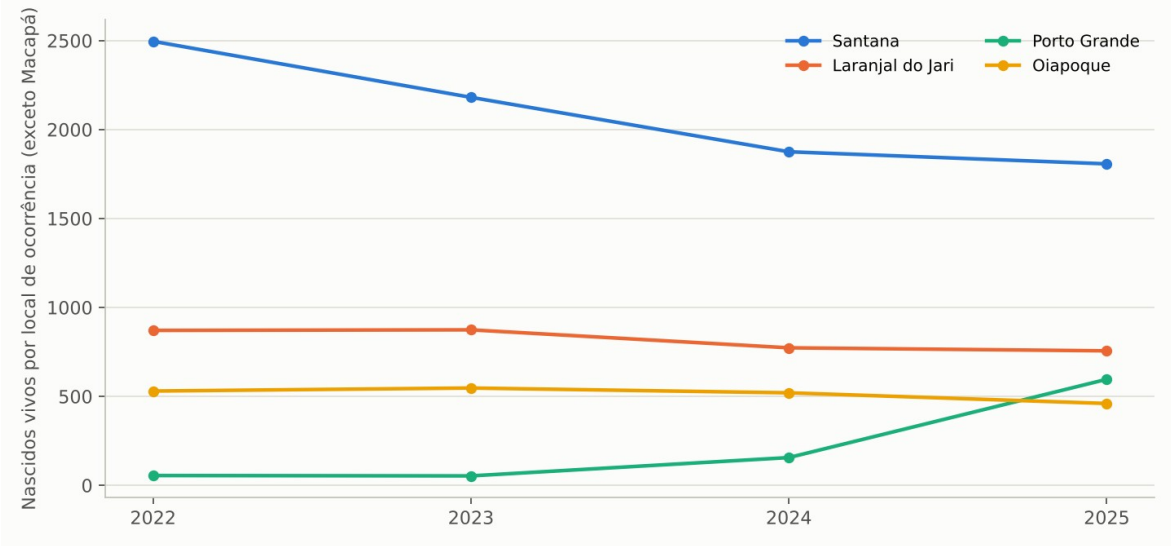
Figura 7 – Proporção de nascidos vivos com sete ou mais consultas de pré-natal por UF, 2024



Fonte: elaboração própria a partir de SINASC/DATASUS (BRASIL, 2026).

O pré-natal adequado avançou dez pontos em três anos (49,6% para 60,3% dos nascidos vivos com sete ou mais consultas), mas o Amapá ainda é a penúltima UF nesse indicador (55,5% em 2024, contra 79,1% no Brasil). As piores coberturas estão em municípios com equipes suficientes no papel (Itaubal, Mazagão, Ferreira Gomes, Cutias), o que indica problema de captação precoce, de registro ou de acesso a exames, e não de número de equipes; Laranjal do Jari (76,7%) mostra que a meta é atingível no interior. A proporção de cesarianas (46,9%) cresceu oito pontos, com Laranjal do Jari, Santana, Macapá e Porto Grande acima de 48%; a classificação de Robson (abas *SINASC_mun_robson_**) mostra que o crescimento está nos grupos 2 e 5 (nulíparas com indução ou cesárea programada e mulheres com cesárea anterior), passíveis de redução com boas práticas obstétricas. A gravidez na adolescência (17,7%) e a prematuridade (13,8%, com 22,0% em Laranjal do Jari) completam o quadro de risco perinatal.

Figura 8 – Nascidos vivos por município de ocorrência do parto, Amapá, 2022–2025 (exceto Macapá)



Fonte: elaboração própria a partir de SINASC/DATASUS (BRASIL, 2026).

Pelo local de ocorrência, Macapá realizou 72% dos partos de 2025 (10.314), Santana 1.807 (2.496 em 2022, queda de 28%), Laranjal do Jari 756, Porto Grande 596 (55 em 2022, com a transformação do Hospital Maria Lúcia Guimarães da Silva em polo de referência da região central) e Oiapoque 460. A redução em Santana, segundo município do estado, merece verificação (capacidade da maternidade do Hospital Estadual de Santana, regulação para Macapá), pois a distância até a capital em trabalho de parto é fator de risco materno e neonatal.

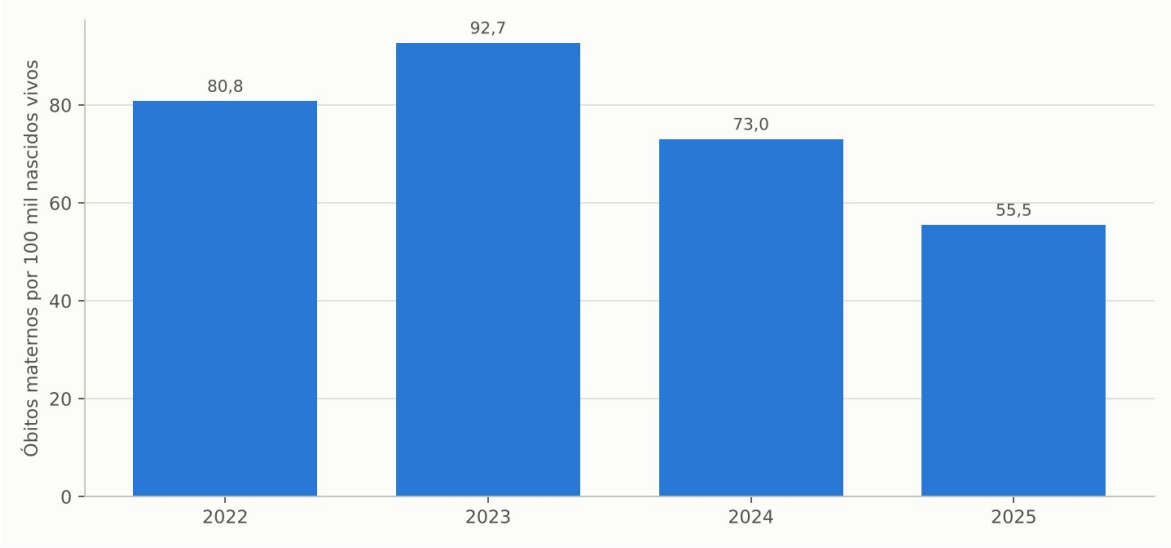
7 MORTALIDADE MATERNA, FETAL E INFANTIL

Tabela 6 – Óbitos maternos, fetais e infantis e indicadores derivados, Amapá, 2022–2026

Indicador	2022	2023	2024	2025*	2026 (parcial)
Nascidos vivos (residência)	13.615	12.948	12.327	12.612	7.386
Óbitos maternos	11	12	9	7	7
Razão de mortalidade materna (por 100 mil NV)	80,8	92,7	73,0	55,5	—
Óbitos fetais	164	166	130	120	83
Taxa de mortalidade fetal (por mil nascimentos)	11,9	12,7	10,4	9,4	—
Óbitos infantis (< 1 ano)	246	271	220	218	130
Taxa de mortalidade infantil (por mil NV)	18,1	20,9	17,8	17,3	—
Óbitos infantis não investigados (%)	32,1	35,1	24,6	31,2	—

*preliminar. Fonte: SIM e SINASC/DATASUS (abas*SIM_materna_ano*, *SIM_fetal_ano*, *SIM_infantil_investigacao_ano*).

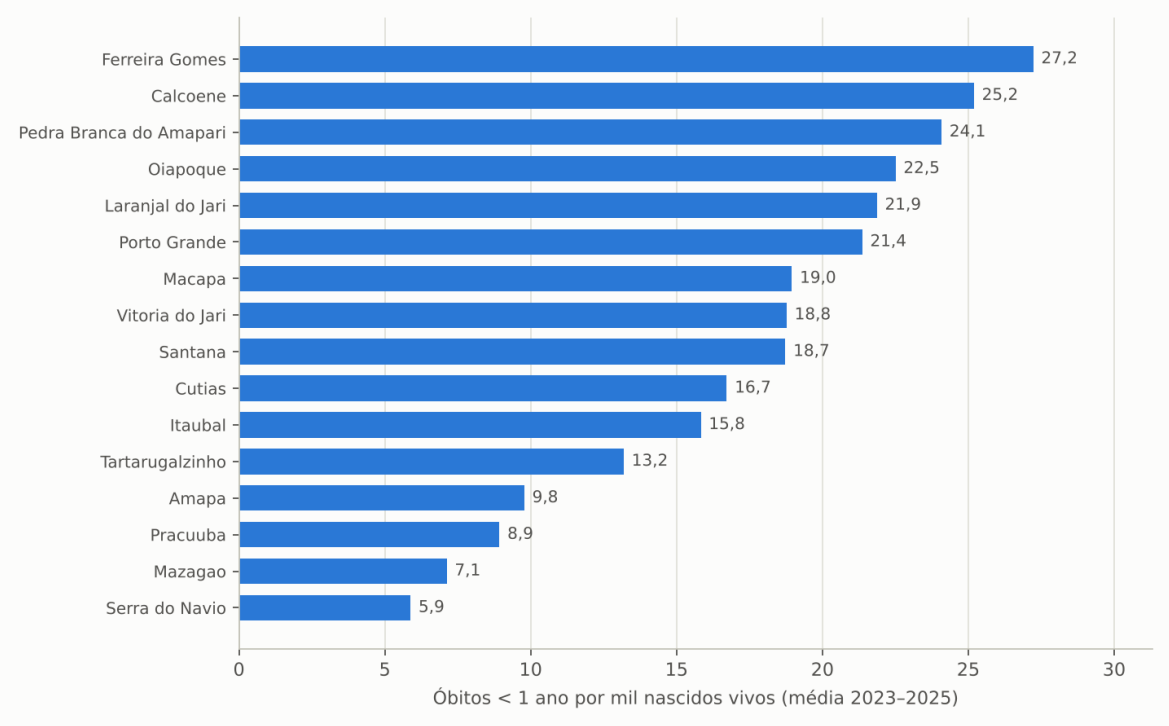
Figura 9 – Razão de mortalidade materna, Amapá, 2022–2025



Fonte: elaboração própria a partir de SIM e SINASC/DATASUS (BRASIL, 2026).

A razão de mortalidade materna do triênio 2022–2024 (82,3 por 100 mil nascidos vivos) é a segunda maior entre as UFs e 53% superior à média nacional (53,7). Dos 39 óbitos maternos de 2022 a 2025, 30 (77%) foram por causas obstétricas diretas, entre elas 8 por transtornos hipertensivos, 8 por complicações do trabalho de parto e do parto e 6 por aborto, todas evitáveis com pré-natal de qualidade, acesso oportuno à maternidade de referência e atenção segura ao abortamento. Todos os óbitos maternos foram investigados, o que permite ao Comitê Estadual de Mortalidade Materna produzir recomendações por caso. Macapá (23 óbitos no período) e Santana (6) concentram as mortes.

Figura 10 – Taxa de mortalidade infantil por município de residência, Amapá, média 2023–2025



Fonte: elaboração própria a partir de SIM e SINASC/DATASUS (BRASIL, 2026).

A mortalidade infantil (17,8 por mil em 2024; 3ª maior do país; Brasil 12,6) tem metade dos óbitos no período neonatal precoce (108 dos 220 óbitos de 2024 entre 0 e 6 dias), 50 por malformações congênitas e 15 por doenças respiratórias. Pela média trienal 2023–2025, os municípios de maior risco são Ferreira Gomes (27,2), Calçoene (25,2), Pedra Branca do Amapari (24,1), Oiapoque (22,5), Laranjal do Jari (21,9) e Porto Grande (21,4); Macapá (19,0) e Santana (18,7) concentram o volume (122 e 39 óbitos em 2024). A investigação dos óbitos infantis, obrigatória, cobre apenas 69% a 75% dos casos, e a dos óbitos fetais 79% (2024), lacuna que impede identificar as falhas assistenciais evitáveis.

8 COMPARATIVO ENTRE UFS

Tabela 7 – Indicadores de atenção primária e materno-infantil: Amapá, Brasil e posição entre as UFs

Indicador	Amapá	Brasil	Posição do AP
Habitantes por equipe de Saúde da Família (set/2026)	2.893	3.720	6ª maior cobertura potencial
Nascidos vivos com 7+ consultas de pré-natal, 2024 (%)	55,5	79,1	26º
Cesáreas, 2024 (%)	43,9	60,6	26º (menor proporção)
Taxa de mortalidade infantil, 2024 (por mil NV)	17,8	12,6	3º
Razão de mortalidade materna, 2022–2024 (por 100 mil NV)	82,3	53,7	2º

Fonte: CNES, SINASC, SIM/DATASUS e IBGE (abas *BENCH_EQUIPES_UF*, *BENCH_MATERNO_INFANTIL_UF*, *BENCH_RMM_UF*).

O contraste entre a sexta maior cobertura potencial de equipes e as piores posições em pré-natal, mortalidade infantil e materna resume o problema da atenção primária no Amapá: a estrutura existe, mas o processo de cuidado (captação precoce da gestante, exames, vinculação à maternidade, acompanhamento de crônicos, vacinação, visita domiciliar) não produz os resultados esperados. A baixa proporção de cesarianas é o único indicador em que o estado está em posição favorável, e deve ser preservada.

9 PONTOS DE ATENÇÃO PARA A TRANSIÇÃO

9.1 Leitos de UTI sem habilitação

120 leitos de UTI adulto, 11 pediátricos e 13 neonatais existentes sem habilitação federal: cada leito habilitado garante custeio por diária; o levantamento das condições de habilitação (RDC 7/2010, equipes, equipamentos) e o envio das solicitações ao Ministério da Saúde são ações imediatas.

9.2 Mortalidade materna e infantil

RMM e TMI entre as três piores do país, com predomínio de causas evitáveis. Prioridade: plano estadual de redução com metas por maternidade e município, investigação de 100% dos óbitos, comitês ativos, qualificação do pré-natal (captação até a 12ª semana, exames, vinculação) e protocolos de hipertensão e hemorragia nas maternidades.

9.3 Cobertura efetiva versus potencial

Equipes suficientes, mas pré-natal insuficiente e ICSAP crescentes: a SESA deve usar os indicadores do SISAB e do cofinanciamento federal por município para apoio institucional e pactuação de metas (pré-natal, hipertensos e diabéticos acompanhados, vacinação, saúde bucal), com atenção a Itaubal, Mazagão, Ferreira Gomes, Cutias e Santana.

9.4 Regionalização do parto e das urgências

Queda dos partos em Santana, concentração em Macapá, novo polo em Porto Grande: revisar o desenho regional das maternidades (Santana, Laranjal, Oiapoque, Porto Grande), o transporte sanitário e a vinculação da gestante à maternidade de referência.

9.5 Doenças crônicas na APS

Crescimento de ICSAP por AVC, diabetes, insuficiência cardíaca e DPOC indica falha no acompanhamento longitudinal; integrar APS, Mais Acesso a Especialistas e telessaúde com protocolos de risco cardiovascular.

9.6 Informação

Sem SISAB, SI-PNI e e-Gestor públicos acessíveis, a transição deve solicitar os painéis municipais à SESA e ao COSEMS e instituir um painel estadual de APS por município.

10 RECOMENDAÇÕES E AGENDA DOS PRIMEIROS 100 DIAS

Documentos e dados a requisitar à SESA e ao COSEMS:

1) Indicadores do SISAB/e-Gestor por município: população cadastrada e vinculada, indicadores do cofinanciamento federal (pré-natal, hipertensão, diabetes, vacinação, saúde bucal, cuidado da pessoa idosa), cobertura vacinal (SI-PNI) 2024–2026.
2) Situação de cada leito de UTI (habilitado, solicitado, apto, inapto) e processos de habilitação pendentes no Ministério da Saúde.
3) Relatórios do Comitê Estadual de Mortalidade Materna e dos comitês de mortalidade infantil e fetal 2022–2026, com recomendações e providências.
4) Mapa das maternidades (leitos obstétricos e neonatais, partos/mês, equipe, cobertura de pediatra e anestesista), fluxos de vinculação e transporte sanitário por região.
5) Contratos e repasses de cofinanciamento estadual da APS e de regionalização (incentivos, consórcios, policlínicas regionais).
6) Produção e metas do Programa Mais Acesso a Especialistas e do Programa de Redução de Filas por estabelecimento.

Prioridades de gestão sugeridas:

1) Protocolar as habilitações de UTI aptas nos primeiros 60 dias e adequar os leitos restantes.
2) Lançar o plano de redução da mortalidade materna e infantil com metas por maternidade e município e investigação integral dos óbitos.
3) Pactuar com os 16 municípios metas de pré-natal (sete consultas, captação precoce, testes e tratamento de sífilis e HIV), de acompanhamento de crônicos e de ICSAP por 10 mil habitantes, com apoio institucional da SESA.
4) Revisar a regionalização das maternidades e das urgências, com atenção a Santana e às regiões Norte e Sudoeste.
5) Integrar telessaúde e especialistas (PMAE) à APS para hipertensão, diabetes, AVC e DPOC, reduzindo as ICSAP.
6) Instituir painel estadual de atenção primária e materno-infantil, publicado mensalmente por município.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entre 2022 e 2026 o Amapá expandiu a estrutura da atenção primária até a cobertura potencial universal e ampliou a rede especializada e de terapia intensiva, mas não converteu a estrutura em resultados: o pré-natal segue entre os piores do país, as internações evitáveis crescem e as mortes maternas e infantis permanecem entre as mais altas do Brasil. A agenda da próxima gestão não é de novas equipes, e sim de qualidade do processo de cuidado, de habilitação do que já existe e de regionalização efetiva das maternidades e urgências, apoiada por um sistema de informação que hoje a Secretaria não disponibiliza ao público.

APÊNDICE A – CONTEÚDO DA PLANILHA DE TABELAS

A planilha *Tabelas_APS_MaternoInfantil_Amapa_2022_2026.xlsx* contém a aba *Indice*, o painel *00_Painel_APS_MaternoInfantil* e as abas *EQUIPES_** (tipo, ESF, eSB, eAP por município), *COBERTURA_APS_mun*, *BENCH_EQUIPES_UF*, *HABILITACOES_**, *UTI_existentes_x_habilitadas*, *SIA_AB_** e *SIA_forma_**, *ICSAP_** e *INTERNACOES_res_cap_ano*, *SINASC_mun_** (pré-natal, parto, peso, idade da mãe, gestação, Robson e local, 2022 e 2025), *SINASC_ocorrencia_mun_ano*, *MATERNO_INFANTIL_mun*, *SIM_infantil_**, *SIM_materna_**, *SIM_fetal_**, *BENCH_RMM_UF*, *BENCH_MATERNO_INFANTIL_UF* e *Fontes_Notas*. Séries recortadas para 2022–2026.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Patrício. **Saúde no Estado do Amapá**: levantamento da produção hospitalar e ambulatorial e estudo analítico para a transição de governo 2026/2027. Macapá, 2026.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico 2022**: população residente por sexo e idade (tabela 9514) e estimativas populacionais (tabela 6579). Rio de Janeiro: IBGE, 2026. Disponível em: https://apisidra.ibge.gov.br. Acesso em: 7 nov. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. **Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)**: equipes de saúde e habilitações – Amapá e Brasil por UF. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?cnes/cnv/equipeap.def. Acesso em: 7 nov. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. **Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)**: produção da atenção básica por município – Amapá. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sia/cnv/qaap.def. Acesso em: 7 nov. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. **Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)**: morbidade hospitalar por local de residência – Amapá. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/nrap.def. Acesso em: 7 nov. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. **Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)**: óbitos maternos, fetais e infantis – Amapá e Brasil por UF. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/mat10ap.def. Acesso em: 7 nov. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. **Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)**: nascidos vivos por município de residência da mãe – Amapá e Brasil por UF. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvap.def. Acesso em: 7 nov. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 22 set. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria SAS nº 221, de 17 de abril de 2008. Lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 18 abr. 2008.